

VIH — Diagnóstico, Clasificación y Tratamiento

Diagnóstico Serológico

TABLA 10.19.1: SITUACIÓN VS EXAMEN		
SITUACIÓN	EXAMEN	RESULTADO
Tamizaje estándar	ELISA (mide anticuerpos)	Positivo → confirmar
Confirmación	Western Blot (más específico)	Positivo = diagnóstico confirmado
Período de ventana (primo-infección)	ELISA y WB falsamente negativos	Usar PCR o Antígeno p24
RN hijo de madre VIH	ELISA y WB falsamente positivos (anticuerpos maternos)	Usar PCR o Antígeno p24

Clasificación por CD4

TABLA 10.19.2: ETAPA VS CD4		
ETAPA	CD4	CONDUCTA
1	> 500/mm³	Monitoreo
2	200–500/mm³	—
3 (mayor inmunosupresión)	< 200/mm³	Iniciar profilaxis para infecciones oportunistas

Clasificación A/B/C (por infecciones)

- Etapa A: Asintomático
- Etapa B: Candidiasis mucocutánea, infecciones bacterianas no recurrentes, displasias
- Etapa C (SIDA): PCP, Toxoplasma, Criptococo, TBC, CMV, MAC, linfomas, cervicouterino

Triterapia Antirretroviral (TARV)

- OMS: TARV para todos los pacientes VIH, independiente del CD4.
- Objetivo salud pública: Regla 90-90-90 (90% diagnosticados → 90% en TARV → 90% con carga viral indetectable).

Profilaxis de Infecciones Oportunistas

TABLA 10.19.3: MICROORGANISMO VS CD4 UMBRAL			
MICROORGANISMO	CD4 UMBRAL	TIPO	FÁRMACO
Pneumocystis jirovecii	< 200	Primaria	Cotrimoxazol
Toxoplasma gondii	< 100	Primaria	Cotrimoxazol
Cryptococcus	< 100	Secundaria (solo si tuvo infección previa)	Fluconazol semanal
CMV	< 50	Secundaria	Ganciclovir
MAC (M. avium complex)	< 50	Primaria	Azitromicina
TBC	PPD ≥ 5 mm	Primaria (independiente de CD4)	Isoniazida 9 meses

VIH y Embarazo — Prevención de Transmisión Vertical

TABLA 10.19.4: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Screening	ELISA VIH en todas las embarazadas al inicio
TARV	Iniciar en semana 20 (o semana 16 si carga viral > 100.000 copias)
Vía de parto	Cesárea (salvo carga viral < 1000 copias → parto vaginal posible)
Durante el parto	Zidovudina IV en bolos
Post-parto	Lactancia materna contraindicada (VIH)

| RN | TARV × 6 semanas + Control con PCR a las 2 semanas, 3 meses y 6 meses |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Recién nacido hijo de madre VIH positiva. Se realiza ELISA VIH al recién nacido que resulta positivo. ¿Cómo interpreta este resultado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para VIH. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico VIH: ELISA (screening) + Western Blot (confirmación), ambos miden anticuerpos. En periodo de ventana y recién nacido de madre VIH: usar PCR o antígeno P24.
- Clasificación por CD4: etapa 1 (>500), etapa 2 (200-500), etapa 3 (<200). Por infecciones: A (asintomática), B (candidiasis mucocutánea, infecciones leves), C (definitorias de SIDA).
- Infección definitiva de SIDA más frecuente: Pneumocystis jirovecii. Segunda: Toxoplasma gondii.
- Profilaxis: cotrimoxazol para Pneumocystis (CD4<200) y toxoplasma (CD4<100). Fluconazol para criptococo (CD4<100, secundaria). Azitromicina para MAC (CD4<50). Isoniazida si PPD>=5mm.
- Triterapia antirretroviral: recomendación OMS para TODOS los pacientes VIH (regla 90-90-90).
- Embarazo: triterapia semana 20, cesárea (vaginal si CV<1000), zidovudina EV en parto, lactancia materna CONTRAINDICADA, RN con triterapia 6 semanas y seguimiento con PCR.
- Periodo de ventana: hasta 3 meses, ELISA falsamente negativo. Hijo de madre VIH: ELISA falsamente positivo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VIH)

PREGUNTA 1

Recién nacido hijo de madre VIH positiva. Se realiza ELISA VIH al recién nacido que resulta positivo. ¿Cómo interpreta este resultado?

- A)** El recién nacido está infectado con VIH, iniciar triterapia definitiva
- B)** Es un falso positivo por traspaso de anticuerpos maternos; confirmar con PCR
- C)** Confirmar con Western Blot para validar el resultado
- D)** Repetir ELISA a los 6 meses cuando desaparezcan los anticuerpos maternos
- E)** El resultado no tiene valor, no se debe hacer ELISA en recién nacidos

PREGUNTA 2

Paciente VIH positivo en control, CD4 de 80/mm³, sin antecedente de infecciones oportunistas. PPD de 7 mm. ¿Cuáles profilaxis debe recibir?

- A)** Cotrimoxazol solamente
- B)** Cotrimoxazol, azitromicina e isoniazida
- C)** Cotrimoxazol, fluconazol, ganciclovir y azitromicina
- D)** Cotrimoxazol y azitromicina solamente
- E)** No requiere profilaxis, solo triterapia antirretroviral

PREGUNTA 3

Mujer embarazada VIH positiva, semana 36, carga viral de 500 copias/mL, en triterapia desde semana 20. ¿Cuál es la vía de parto más adecuada?

- A)** Cesárea electiva obligatoria
- B)** Parto vaginal, ya que la carga viral es menor a 1.000 copias
- C)** Parto vaginal solo si la carga viral es indetectable (0 copias)
- D)** Cesárea con carga de zidovudina endovenosa, independiente de la carga viral
- E)** Inducción del parto vaginal a las 37 semanas

RESUMEN: VIH

Esta clase aborda el VIH: vías de contagio, diagnóstico, clasificación, tratamiento y manejo en embarazo. Las vías de contagio son sexual (más frecuente en Chile), parenteral y vertical. El diagnóstico se hace con ELISA (repetido si positivo) confirmado con Western Blot, ambos miden anticuerpos. Las excepciones son el periodo de ventana (falso negativo, hasta 3 meses) y el recién nacido de madre VIH (falso positivo por anticuerpos maternos), donde se usa PCR o antígeno P24. La clasificación según CD4 es: etapa 1 (>500), etapa 2 (200-500), etapa 3 (<200, profilaxis de infecciones oportunistas). Según infecciones oportunistas: etapa A (asintomática), etapa B (candidiasis mucocutáneas, infecciones bacterianas no recurrentes, displasias), etapa C (enfermedades definitorias de SIDA: *Pneumocystis jirovecii* la más frecuente, toxoplasma, criptococo, candidiasis invasiva, TBC, linfoma, etc.). El tratamiento incluye triterapia antirretroviral (recomendación OMS: para todos), profilaxis de infecciones oportunistas (cotrimoxazol para *Pneumocystis* con CD4<200 y toxoplasma con CD4<100; fluconazol para criptococo CD4<100 solo secundaria; azitromicina para MAC con CD4<50; isoniazida si PPD positivo) y tratamiento de las infecciones oportunistas. En el embarazo: screening con ELISA al inicio, triterapia desde semana 20 (semana 16 si carga viral >100.000), cesárea (parto vaginal solo si carga viral <1.000 copias), zidovudina endovenosa durante el parto, lactancia materna contraindicada, recién nacido con triterapia 6 semanas y seguimiento con PCR.